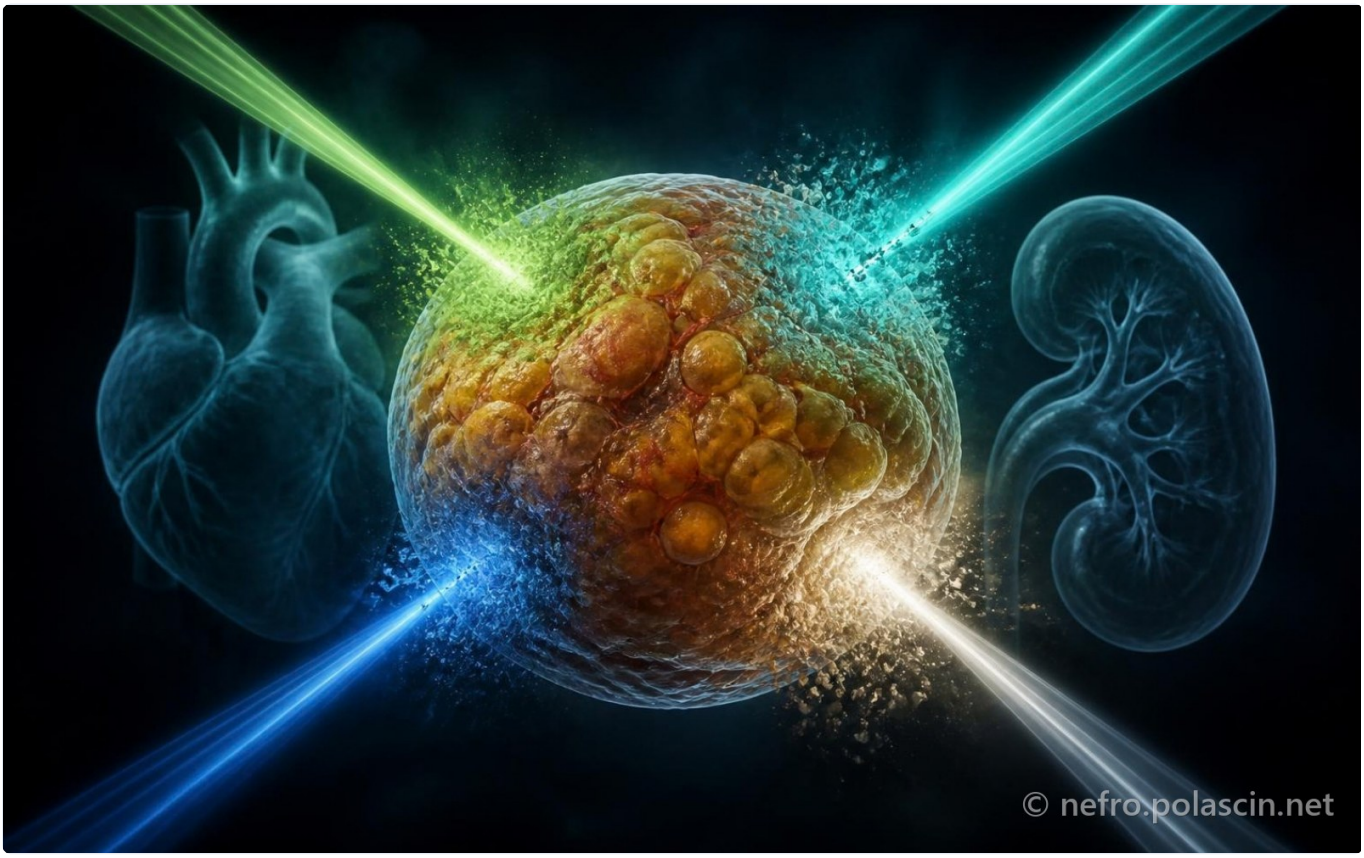
Obezita a kardiometabolické zdravie pri chorobe obličiek: od životného štýlu k viaczložkovej stratégii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.09.2026



Ilustračná scéna. Obezita pri chorobe obličiek zriedka ustúpi jednému opatreniu – účinok prichádza zo súbehu viacerých zložiek naraz.

Obezita už dávno nie je len sprievodným javom chronickej choroby obličiek (CKD). Je samostatným patofyziologickým činiteľom, ktorý zvyšuje riziko vzniku aj progresie ochorenia obličiek, urýchľuje kardiovaskulárne komplikácie a zhoršuje metabolický profil pacienta. Prehľadová práca Mathewa a kolektívu, publikovaná v roku 2026 v časopise *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, tieto väzby zhŕňa v rámci **kardio-obličkovo-metabolického (CKM) rámca**.

Pre nefrologickú prax je podstatný posun v uvažovaní: obezitu netreba vnímať ako komorbiditu vedľa CKD, ale ako stav, ktorý priamo ovplyvňuje hemodynamiku obličky, zápal, glomerulárny tlak, albuminúriu aj dlhodobú prognózu.

Ako obezita poškodzuje obličku

Prehľad rozlišuje **priame a nepriame mechanizmy**, čo sa pri klinickom uvažovaní osvedčuje:

Dráha	Mechanizmus	Klinický prejav
Priama	Glomerulárna hyperfiltrácia a zvýšený intraglomerulárny tlak	Proteinúria, zväčšenie glomerulov, poškodenie podocytov
Priama	Tubulárne poškodenie	Tubulointersticiálne zmeny nezávislé od glomerulárnej dráhy
Nepriama	Diabetes, hypertenzia, kardiovaskulárno-metabolické ochorenie	Progresia CKD cez etablované rizikové faktory

K tomu sa pridáva zápalová a hormonálna aktivita tukového tkaniva. Tukové tkanivo nie je pasívnym zásobným

orgánom – produkuje cytokíny a adipokíny, ktoré prispievajú k systémovému zápalu, endotelovej dysfunkcii, inzulínovej rezistencii a fibrotizácii. Obezita zároveň podporuje aktiváciu systému renín–angiotenzín–aldosterón a sympatikového nervového systému, čo zhoršuje hypertenziu aj tlakové zaťaženie glomerulu.

Klinicky podstatné je, že obezita môže poškodzovať obličku **aj bez prítomnosti diabetu**. Tento obraz sa označuje ako obezitná glomerulopatia a typicky sa prejavuje proteinúriou s pomalou progresiou. Môže sa však kombinovať s inými nefropatiami a urýchľovať ich priebeh.

Nie hmotnosť, ale rozloženie tuku

Jedným z najpraktickejších posolstiev prehľadu je, že **rozloženie tukového tkaniva ovplyvňuje poškodenie cieľových orgánov**. Pribúdajú dôkazy, že s CKD súvisia predovšetkým **viscerálne a ektopické perirenálne tukové depozity** – nie samotná celková hmotnosť.

Populačné štúdie to potvrdzujú: ukazovatele adipozity sa spájajú s vyšším rizikom vzniku CKD, jej progresie aj zlyhania obličiek.

Pre hodnotenie pacienta to má priamy dôsledok. **Index telesnej hmotnosti (BMI) je praktický, ale sám osebe nedostatočný.** U niektorých pacientov neodráža ani metabolické riziko, ani zloženie tela – najmä u starších osôb, pri sarkopénii a pri chronickom ochorení. Pri hodnotení preto patrí k BMI aj obvod pása, posúdenie viscerálnej adipozity, krvný tlak, glykemický stav, albuminúria, eGFR, lipidový profil, známky spánkového apnoe a funkčná zdatnosť vrátane rizika sarkopénie.

Posun v liečbe: od režimu k viaczložkovej stratégii

Hlavná téza prehľadu je, že s príchodom novších liekov sa manažment obezity pri CKD **presunul od prevažne režimového prístupu k ucelenej viaczložkovej stratégii**. Tá kombinuje farmakoterapiu s preukázaným kardio-obličkovo-metabolickým prínosom so štruktúrovaným nutričným vedením, individualizovanou pohybovou aktivitou a dlhodobou behaviorálnou podporou.

Režimové opatrenia

Základom zostáva energetická reštrikcia, zvýšenie pohybovej aktivity, obmedzenie ultraspracovaných potravín, primeraný príjem bielkovín a dlhodobá edukácia. Samotná režimová intervencia však býva nedostatočná, ak nie je sprevádzaná multidisciplinárnou starostlivosťou – a to nie je zlyhanie pacienta, ale očakávaný priebeh.

Inkretínová liečba

Prehľad označuje inkretínovú liečbu za prístup, ktorý **predefinoval liečebné postupy**. Agonisty receptora GLP-1 a duálne inkretínové agonisty pôsobia súčasne na metabolickú dysfunkciu, progresiu CKD aj kardiovaskulárne riziko.

Pripravované sú **trojité inkretínové agonisty**, ktoré sľubujú ešte väčšiu účinnosť v redukcii hmotnosti a metabolickej kontrole. Tu však prehľad výslovne upozorňuje, že **údaje o ich účinnosti a bezpečnosti pri chorobe obličiek zostávajú obmedzené** – ide o očakávanie, nie o doložený prínos.

Pre nefrológa je pri inkretínovej liečbe podstatné sledovať znášanlivosť, objemový stav, gastrointestinálne nežiaduce účinky, nutričný stav a možné interakcie s ostatnou liečbou.

Inhibítory SGLT2

Inhibítory SGLT2 navodzujú **mierny úbytok hmotnosti**, a to prevažne stratou kalórií pri glykozúrii, pričom súčasne poskytujú kardio-obličkovú ochranu. Ich úloha pri obezite je teda doplnková – nie sú liekom na chudnutie, ale ich metabolický účinok je vítaným doplnkom liečby, ktorá je pri CKD indikovaná z iných dôvodov.

Bariatrická a metabolická chirurgia

Klinické štúdie ukazujú, že bariatrická chirurgia dosahuje **podstatný úbytok hmotnosti** a pri CKD sa spája so zlepšením kardio-obličkových výsledkov. U pacientov s CKD môže priniesť zlepšenie hypertenzie, redukciu proteinúrie a zlepšenie kontroly diabetu.

Treba však počítať s perioperačnými komplikáciami, výživovými deficitmi, rizikom nefrolitiázy a s potrebou dlhodobého sledovania minerálov, vitamínov a nutričného stavu. U pacienta s CKD je riziko oxalátovej

nefrolitiázy po malabsorpčných výkonoch osobitne relevantné.

Opatrná interpretácia takzvaného obezitného paradoxu

V nefrológii sa dlhodobo diskutuje pozorovanie, že u niektorých skupín chronicky chorých – najmä u dialyzovaných pacientov – sa vyšší BMI spája s lepším prežívaním. Tento nález nemožno interpretovať zjednodušene.

Medzi možné vysvetlenia patrí obrátená kauzalita, vplyv sarkopénie a kachexie, rozdiel medzi BMI a skutočným metabolickým rizikom a výberové skreslenie v kohortách. Pre prax z toho vyplýva, že obezita zostáva rizikovým faktorom, redukcia hmotnosti však musí byť individualizovaná a cieľom nie je nižšie číslo na váhe, ale lepšie kardiometabolické a obličkové zdravie pri zachovaní svalovej hmoty.

Praktické odporúčania pre nefrologickú prax

1. U každého pacienta s CKD aktívne hodnotiť obezitu, metabolické riziko a kardiovaskulárne komorbidity – nie iba zaznamenať hmotnosť.
2. Nepodceňovať albuminúriu a krvný tlak; pri obezite môžu byť prvými známkami poškodenia obličiek.
3. Hodnotiť **rozloženie tuku**, nie iba BMI; pri sarkopénii a u starších pacientov je BMI obzvlášť nespoľahlivé.
4. U vhodných pacientov zvážiť inkretínovú liečbu s preukázaným kardio-obličkovým prínosom, pri trojitých agonistoch však počítať s obmedzenými dátami pri CKD.
5. Pri ťažkej obezite posúdiť indikáciu bariatrickej alebo metabolickej chirurgie vrátane plánu dlhodobého nutričného sledovania.
6. Využívať multidisciplinárny model – nefrológ, diabetológ, kardiológ, nutričný špecialista a obezitológ.
7. Komunikovať bez stigmatizácie; stigmatizujúci prístup znižuje adherenciu a je sám osebe prekážkou úspešnej liečby.

Limity

Ide o **naratívny prehľad**, nie o systematickú syntézu s vlastnou metaanalýzou. Zhŕňa dôkazy rôznej sily – od populačných asociačných štúdií cez randomizované skúšania inkretínovej liečby až po observačné údaje o bariatrickej chirurgii. Odporúčanie stupňovitého postupu je expertné, nie gradované. Pri trojitých inkretínových agonistoch a pri viacerých postupoch v pokročilých štádiách CKD dôkazy stále chýbajú.

Záver

Obezita je pri CKD kľúčovým modifikovateľným činiteľom, ktorý zasahuje do patogenézy aj prognózy. V rámci CKM prestáva byť samostatným pridruženým problémom a stáva sa súčasťou liečebnej stratégie.

Pre klinickú prax je najdôležitejšie myslieť na obezitu ako na ochorenie s obličkovými dôsledkami, sledovať pacienta komplexne a nie iba podľa BMI, cielene liečiť metabolické a kardiovaskulárne riziko a u vhodných pacientov využiť moderné farmakologické aj chirurgické možnosti – s vedomím, kde dôkazy pri chorobe obličiek ešte končia.

Súvisiace články na portáli

- Obezita a obličky
- Oblička v strede pozornosti: KDIGO a CKM syndróm
- Farmakologická liečba obezity pri pokročilej CKD a na dialýze
- Obezita ako multifaktoriálne ochorenie: skríning v nefrologickej praxi
- Éra GLP-1: nový model starostlivosti o obezitu v nefrológii

---

Hlavný zdroj: *Mathew RO, Hong A, Narasaki Y, Fung E, Cheung D, Han J, Durstenfeld MS, Hsue PY, Rhee CM. Obesity and Cardio-Metabolic Health in Kidney Disease: Implications for Kidney Health, Risk Stratification, and Management. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2026. doi:10.2215/CJN.0000001233. PMID*

42726513. DOI; PubMed.

Ďalšie zdroje:

1. *Ndumele CE, Neeland IJ, Tuttle KR, a kol. A Synopsis of the Evidence for the Science and Clinical Management of Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Syndrome: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2023;148(20):1636–1664. doi:10.1161/CIR.0000000000001186. PMID 37807920. DOI; PubMed.*
2. *Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, a kol. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2016;375(4):323–334. doi:10.1056/NEJMoa1515920. PMID 27299675. DOI; PubMed.*
3. *Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, a kol. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine. 2020;383(15):1436–1446. doi:10.1056/NEJMoa2024816. PMID 32970396. DOI; PubMed.*
4. *Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, a kol. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. New England Journal of Medicine. 2022;387(3):205–216. doi:10.1056/NEJMoa2206038. PMID 35658024. DOI; PubMed.*
5. *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. kdigo.org.*
6. *KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. kdigo.org.*

Bibliografické údaje boli overené v databáze PubMed 17. septembra 2026. Ide o naratívny prehľad; odporúčania v ňom nie sú gradované. Text nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani schválenú informáciu o lieku.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=obezita-kardiometabolicke-zdravie-ckd-ckm-ramec · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.